2026
ISSN 2237-9223

REVISTA BRASILEIRA DE CRIMINALÍSTICA

Edição Especial dos Anais do

PERÍCIAS MÉDICAS, PSÍQUICAS E ANTROPOLÓGICAS

Corpos negros, laudos brancos: vieses raciais na produção de diagnósticos e laudos psiquiátricos

A. O. Castro[a,*], M. M. S. Cruz[b], A. M. Cunha[b], R. Sepúlveda[b], L. E. M. Santos[c], A. Santos[b], E. Moreira[b]

[a]*Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre (UFCSPA); Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), Porto Alegre (RS), Brasil*

[b]*Universidade Federal do Paraná (UFPR), Curitiba (PR), Brasil*

[c]*Universidade Positivo, Curitiba (PR), Brasil*

**Endereço de e-mail para correspondência: aocas57@gmail.com. Tel.: +55-41-99871-2022.*

Palavras-chave: Racismo estrutural; Psiquiatria; Diagnóstico psiquiátrico; Saúde mental; Laudo psiquiátrico

1. INTRODUÇÃO

1.1. Revisão bibliográfica

A psiquiatria contemporânea carrega o legado de sua construção eurocêntrica, manifesto em vieses diagnósticos estruturados por marcadores raciais. Pessoas negras foram sistematicamente associadas a imoralidade e criminalidade inatas, transformando o diagnóstico psiquiátrico em instrumento de controle social e estigmatização. (American Psychiatric Association, 2021.)

Embora o conceito biológico de raça não possua sustentação científica, os processos de racialização continuam impactando experiências sociais, acesso aos serviços de saúde e interpretações clínicas (JESTE et al., 2022). Nesse contexto, indivíduos negros frequentemente estão associados, em imaginário social e institucional, com características como agressividade, impulsividade e descontrole emocional, o que pode influenciar avaliações psiquiátricas e decisões terapêuticas (FABER et al., 2023). Estudos demonstram que pacientes negros apresentam maior probabilidade de receber diagnósticos relacionados a transtornos psicóticos quando comparados a pacientes brancos com sintomas semelhantes, mesmo após controle de variáveis clínicas e sociodemográficas, evidenciando a presença de vieses raciais implícitos na prática psiquiátrica (ANTHONY et al., 2021; FABER et al., 2023; JESTE et al., 2022).

1.2. Objetivos

Analisar a influência de marcadores raciais na elaboração e interpretação de laudos psiquiátricos, discutindo os impactos do racismo estrutural sobre diagnósticos, condutas terapêuticas e processos de patologização de indivíduos negros.

2. METODOLOGIA

Trata-se de uma revisão narrativa da literatura. Foram analisados artigos científicos e documentos institucionais publicados entre 2021 e 2024, disponíveis nas bases PubMed e PsycINFO, utilizando os descritores "racismo", "diagnóstico psiquiátrico", "preconceito racial" e "saúde mental negra". Foram incluídos estudos relacionados a visões raciais em avaliações psiquiátricas, disparidades diagnósticas entre grupos raciais e impactos do racismo estrutural na saúde mental..

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os estudos analisados demonstram que pacientes negros são apresentados com maior frequência com o diagnóstisco esquizofrenia (CID 10 F20.0) e transtornos do espectro psicótico, enquanto pacientes brancos tendem a receber mais diagnósticos relacionados a transtornos de humor, como transtorno de humor bipolar e depressão, mesmo diante de apresentações clínicas semelhantes (ANTHONY et al., 2021; FABER et al., 2023; JESTE et al., 2022). Tal discre-

pância sugere a permanência de estereótipos raciais no imaginário médico e institucional.

Descritores clínicos como hostilidade, desconfiança e periculosidade aparecem com maior frequência associada a pacientes negros, influenciando interpretações diagnósticas e decisões terapêuticas subsequentes (ANTHONY et al., 2021). Além disso, expressões emocionais, linguagem corporal e manifestações de sofrimento psíquico de indivíduos negros tendem a ser interpretadas de maneira mais patologizante (FABER et al., 2023; KUNSTMAN et al., 2023).

Kunstman et al. (2023) demonstram que tantos profissionais quanto leigos frequentemente percebem o sofrimento psicológico de pessoas negras como menos intenso ou menos incapacitante quando comparados a indivíduos brancos, afetando julgamentos relacionados à necessidade de cuidado e tratamento. Essas percepções podem contribuir para atrasos, diagnósticos, condutas prejudiciais e menor acesso a intervenções terapêuticas.

Como consequência dessas disparidades, pacientes negros apresentam maior probabilidade de receber antipsicóticos de geração, em doses mais elevadas, primeiramente de maior exposição a tratamentos coercitivos, contenção física e formulações injetáveis de longa duração (ANTHONY et al., 2021; FABER et al., 2023). Também são observadas trajetórias de cuidado marcadas por menor continuidade do acompanhamento ambulatorial e desfechos em saúde mental (FABER et al., 2023).

A literatura destaca ainda que o racismo atua em níveis interpessoais, institucionais e estruturais, produzindo impactos diretos sobre a saúde mental, acesso aos serviços e qualidade do cuidado oferecido (COGBURN et al., 2024; JESTE et al., 2022). Nesse cenário, os laudos psiquiátricos deixam de constituir instrumentos limitados técnicos e passam a refletir contextos históricos, sociais e institucionais que influenciam a prática clínica.

4. CONCLUSÕES

Conclui-se que a produção de diagnósticos e laudos psiquiátricos pode ser influenciada por visões raciais historicamente construídas e reproduzidas em práticas institucionais contemporâneas. As evidências demonstradas nos artigos analisados apontam para desigualdades diagnósticas e terapêuticas que afetam desproporcionalmente indivíduos de etnia negra, especialmente no contexto dos transtornos psicóticos. Desta forma, torna-se relevante ampliar a investigação sobre racismo estrutural, formação profissional e interpretação diagnóstica na psiquiatria, para alcançar maior rigor clínico e redução de disparidades no cuidado em saúde mental da população.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

[1] J. R. Anthony, et al. Reference document on advocating for antiracist mental health policies focusing on dismantling racism against Black people. Washington: American Psychiatric Association, 2021. Retirado em 25 de maio de 2026.

[2] C. D. Cogburn, Roberts SK, Ransome Y, Addy N, Hansen H, Jordan A. The impact of racism on Black American mental health. Lancet Psychiatry. 2024 Jan;11(1):56-64. doi: 10.1016/S2215-0366(23)00361-9. (2024). Retirado em 27 de maio de 2026, de https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/38101873

[3] S.C. Faber, Khanna Roy A, Michaels TI, Williams MT. The weaponization of medicine: Early psychosis in the Black community and the need for racially informed mental healthcare. Front Psychiatry. 2023 Feb 9;14:1098292. doi: 10.3389/fpsyt.2023.1098292. PMID: 36846217; PMCID: PMC9947477. Retirado em 27 de maio de 2026, de https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36846217

[4] D.V. Jeste, et al. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-5-TR): impact of racism and discrimination on psychiatric diagnosis. Washington: American Psychiatric Association, 2022. Retirado em 28 de maio de 2026.

[5] J. W. Kunstman, T. Ogungbadero, J.C. Deska, M.J. Bernstein, A. R. Smith, K. Hugenberg. Race-based biases in psychological distress and treatment judgments. PLoS One. 2023 Oct 19;18(10):e0293078. doi: 10.1371/journal.pone.0293078. PMID: 37856467; PMCID: PMC10586605. Retirado em 28 de maio de 2026, de https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/37856467